

Reunião - Médico de Família

Funcionalidades Desejadas:

- Resumo estruturado e automático que obtenha de forma estruturada os seguintes campos:
 - Diagnósticos (Lista de problemas)
 - Notas de alta
 - Antecedentes
 - Prescrições anteriores
 - Alergias
- Integração com o SClinico

Motivação: Aumento de teleconsultas leva a que o médico que está a ver um utente pela primeira vez tenha de pesquisar exaustivamente para conhecer o doente que tem há frente, logo uma ferramenta que resumi-se estes aspetos ajudaria bastante.

Fluxo atual: Médico verifica consultas anteriores, doenças anteriores, consultas exteriores, diagnósticos, consultas de urgência e prescrições anteriores.

Reunião - Oncologia

Funcionalidades desejadas:

- Botão mágico -> extraí automaticamente informação de forma estruturada
 - Diagnóstico, estágio, Tratamento, Data 1º tratamento
 - Existem erros ortográficos pode ser necessária normalização da linguagem
- Sinalizar análises alteradas (Existe um delay de meses)
- Conseguir obter informação em tempo real
- Motor de pesquisa
 - Isto viria diretamente da extração de informação estruturada
- Estimativa de doentes elegíveis a um ensaio clínico
 - Pode ser necessário algum tipo de input do médico como que parâmetros tornariam estes doentes elegíveis

Motivação:

- Existem muitos doentes em serviços oncológicos
- Taxa de burnout dos oncologistas é muito alta
- Incomprimento de doentes propostos a ensaio clínico leva a uma penalização monetária

Reunião - Genómica

Funcionalidades desejadas:

- Migração automática de dados do SClinico para a plataforma do BioBanco
 - Género
 - Data de nascimento: MM/AAAA
 - Idade
 - Diagnósticos (ICD10)
 - Comorbilidades
 - Tratamentos em curso
- Preenchimento automático dos campos definidos por cada coleção
- Ligação entre código do BioBanco e Dados clínicos (pseudoanonimização)
- Relacionar amostras com dados clínicos anonimizados
- Obtenção de mais dados do utente posteriormente à primeira recolha de dados

Motivação:

- O software atual obriga a ser feito um contrato para a manutenção do mesmo de forma anual oque é um problema
- A elaboração deste software será um passo fundamental para a medicina personalizada, para estar num patamar de competitividade com outros países
- Início para outros projetos propostos ao BioBanco
- Permitirá alargar todos as áreas da ULS Coimbra
- Extração manual de dados clínicos não é viável pois são milhares de dados e não há mão de obra para tal
- Amostras sem os dados clínicos do utente não têm valor científico

Reunião - Urgências

Funcionalidades desejadas:

- Extração automática de informação clínica de texto livre do SClinico
- Preenchimento automático de campos estruturados:
 - Diagnósticos (CD10)
 - Alergias
 - Motivo da última urgência
 - Antecedentes médicos
 - Medicação em curso
 - Instituição de seguimento

- Últimas orientações dadas em consultas anteriores
- Orientações dos cuidados primários
- Migração de informação estruturada para a plataforma com adição de texto livre
- Melhoria dos relatórios de alta

Motivação:

- Médicos sem paciência para preencher formulários estruturados (Prisma)
- Pressão elevada na urgência com muitos doentes
- Obrigatoriedade de diagnóstico para dar alta
- Códigos IC10 criados para fins contabilísticos e não clínicos
- Profissionais saturados devido ao excesso de trabalho
- Seleção automática de doentes para ensaios clínicos baseada em características específicas

Notas: Maioria de doente que sai com código RC69 que é registo de doença, forma do médico despachar o processo. Ainda existe gente que ao invés de usar a metodologia estruturada ainda criam relatórios à parte para a realização de relatórios de alta. Nas urgências faz se printscreens dos diários clínicos e é isto o enviado ao médico de família. Percentagem grande de doentes com campos incorretos no SClinico

Reunião - AVC

Funcionalidades desejadas:

- Extração de dados de:
 - Diários clínicos
 - Notas de alta
- Campos a recolher:
 - Dados demográficos (idade, etc.)
 - Medicação prévia
 - Tempos críticos:
 - Admissão no hospital
 - Sintomas porta
 - Admissão na urgência
 - Momento da TAC
 - Porta agulha
- Garantir acompanhamento do doente aos 3 meses

Motivação:

- AVC é a principal causa de morte em Portugal
- Não existe registo automático dos parâmetros nas diferentes fases
- Falta de comparação e avaliação da qualidade do trabalho
- Tempos de intervenção apertados são críticos para o desfecho clínico
- Registo manual consome muitas horas e recursos humanos
- Muitos hospitais portugueses não registam todos os doentes com AVC
- Adaptabilidade do sistema para outras patologias a nível nacional
- Necessidade de anonimização de dados
- Cumprimento dos golden standards internacionais